

TEMA 3.13 • ENDOCRINOLOGÍA

Manejo del Cáncer de Tiroides

PERFIL EUNACOM 1.03.2.011  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Bocio

Definición

Aumento de volumen de la glándula tiroides. No implica disfunción tiroidea.

Clasificación según función

| TABLA 3.13.1: TIPO VS TSH |        |          |                                   |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------|
| TIPO                      | TSH    | T4 LIBRE | CAUSA EJEMPLO                     |
| Eutiroideo                | Normal | Normal   | Bocio simple, deficiencia de yodo |
| Hipotiroideo              | ↑      | ↓        | Hashimoto, déficit de yodo        |
| Hipertiroideo             | ↓      | ↑        | Graves, bocio multinodular tóxico |

Causas

- **Déficit de yodo** → causa más frecuente mundial de bocio
- **Tiroiditis de Hashimoto** (autoinmune)
- **Enfermedad de Graves-Basedow**
- **Bocio multinodular** (simple o tóxico)
- Fármacos bociógenos: litio, amiodarona

Estudio

- **TSH** → define si hay disfunción
- **Ecografía tiroidea** → tamaño, estructura, nódulos
- Si hay nódulos → seguir algoritmo del **nódulo tiroideo** (TI-RADS + PAAF si corresponde)

Tratamiento

- Tratar la causa de la disfunción (si la hay)

- Bocio eutiroideo simple: observar; si hay síntomas compresivos → considerar cirugía
- Déficit de yodo → yoduro de potasio o sal yodada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con cáncer medular de tiroides confirmado por PAAF. ¿Cuál es el examen que se debe solicitar ANTES de la tiroidectomía?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo del Cáncer de Tiroides. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Papilar (85%) + folicular (10-15%) = cáncer diferenciado. Mismo manejo: tiroidectomía total + levotiroxina supresiva + yodo radioactivo.
- Objetivo TSH en cáncer: 0,1-0,4 (bajo riesgo) o <0,1 (alto riesgo). Más suprimido que en hipotiroidismo normal.
- Seguimiento del diferenciado: tiroglobulina + TSH + ecografía.
- Cáncer medular: células C, asociado a NEM 2. ANTES de operar: descartar feocromocitoma con metanefrinas urinarias.
- Cáncer medular NO responde a yodo radioactivo. Seguimiento con calcitonina.
- Cáncer anaplásico: mal pronóstico, tratamiento principalmente paliativo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DEL CÁNCER DE TIROIDES)

PREGUNTA 1

Paciente con cáncer medular de tiroides confirmado por PAAF. ¿Cuál es el examen que se debe solicitar ANTES de la tiroidectomía?

- A) Tiroglobulina sérica
- B) Cintigrafía con yodo radioactivo
- C) Metanefrinas y catecolaminas en orina
- D) TSH y T4 libre
- E) PET-CT

RESUMEN: MANEJO DEL CÁNCER DE TIROIDES

El cáncer de tiroides se diagnostica mediante PAAF en contexto del estudio del nódulo tiroideo. Histología: papilar (85%, más frecuente y mejor pronóstico), folicular (10-15%). Ambos = cáncer diferenciado. Manejo: tiroidectomía total + levotiroxina (supresiva con TSH objetivo 0,1-0,4, o <0,1 si alto riesgo) + yodo radioactivo (captan yodo). Seguimiento con tiroglobulina + TSH + ecografía. Cáncer medular (5%): células C/parafoliculares, asociado a NEM tipo 2. Antes de operar: pedir metanefrinas/catecolaminas urinarias para descartar feocromocitoma. No responde a yodo radioactivo. Seguimiento con calcitonina. Cáncer anaplásico: mal pronóstico, tratamiento paliativo.